

MATERIAL CLÍNICO EDUCATIVO

Checklist de *Sinais de Atenção*

Ferramenta de apoio à decisão clínica

Dra. Tatiana Gontijo
Especialista em Saúde Mental

Expediente

Checklist de Sinais de Atenção

Dra. Tatiana Gontijo

Todos os direitos reservados.

É permitida a reprodução parcial deste material apenas com citação da fonte.

ISBN digital: [a definir]

Edição: 1ª edição

Ano: 2026

Publicado no Brasil

Edição e distribuição

[Nome editorial / selo]

Contato: <https://dratatianagontijo.com.br>

Equipe técnica

Autoria: Tatiana Paranhos de Campos Gontijo

Diagramação: Thiago José Gontijo Cardoso

Sumário

ABERTURA

Introdução	4
Como usar este checklist	5

CONTEÚDO CLÍNICO

Seção 1	Sinais Psiquiátricos	6
Seção 2	Sinais Medicamentosos	8
Seção 3	Sinais Clínicos / Orgânicos	11
Seção 4	Frases de Apoio para Momentos Críticos	13
Comunicação com o psiquiatra		14
Versão Resumida	Referência Rápida	15

Introdução

Você percebe algo diferente no paciente. A sessão andou, o vínculo está ali, mas tem algo que não fecha. Pode ser a forma como ele chegou hoje: mais apagado, mais acelerado, mais distante. Pode ser uma fala que ficou na memória: "estou estranho", "não sei o que mudou", "estou tomando o remédio, mas não está funcionando". Você não ignora. Mas também não sabe exatamente o que nomear.

Este checklist foi criado para esse momento. Não para transformar o terapeuta em psiquiatra, e sim para dar forma ao que ele já percebe. Cada sinal descrito aqui representa uma situação clínica que pode aparecer na sessão e que merece atenção objetiva: uma pergunta mais precisa, um registro mais cuidadoso, ou uma comunicação com o médico responsável.

Na minha prática clínica, no pronto-socorro, na clínica psiquiátrica e no consultório, aprendi que o terapeuta frequentemente percebe sinais antes de qualquer outro profissional da equipe. Ele tem o que ninguém mais tem: continuidade. Vê o paciente toda semana, conhece sua linha de base, nota quando algo mudou. O problema raramente é falta de sensibilidade clínica. É falta de um roteiro que ajude a organizar o que já se percebe.

O material está organizado em quatro blocos: sinais psiquiátricos, medicamentosos, clínicos e orgânicos, seguidos de frases de apoio para momentos críticos e um roteiro de comunicação com o psiquiatra. Cada sinal é apresentado com o que ele pode parecer na sessão, uma pergunta-chave para investigação e uma orientação de conduta. A versão resumida ao final pode ser mantida no consultório como referência de acesso rápido.

O que este checklist faz — e o que foi pensado para fazer — é organizar a observação, para que o próximo passo seja tomado com mais clareza e menos hesitação.

Dra. Tatiana Gontijo

Como usar este checklist

Este material não substitui o julgamento clínico. Ele organiza o que você já percebe na sessão e te ajuda a decidir o próximo passo com mais clareza.

Este checklist reúne sinais que já merecem atenção clínica. Por isso, ele não usa uma categoria neutra de acompanhamento: se o sinal entrou aqui, a pergunta é qual é o grau de urgência.

Regra prática: na dúvida entre duas cores, use a mais intensa. Errar para o lado da cautela protege o paciente.

Sistema de atenção por cores: Amarelo = alinhar com o psiquiatra em breve (em dias, não semanas). Vermelho = agir hoje (acionar psiquiatra, rede de apoio e emergência quando necessário).

Fique mais atento nos seguintes contextos: início de medicação, troca ou ajuste de dose, e suspensão recente de qualquer medicamento.

Nota ética: quando houver necessidade de compartilhar informações com psiquiatra, familiar ou serviço de urgência, compartilhe apenas o necessário para proteger o paciente e sustentar a conduta.

SEÇÃO 01

Sinais Psiquiátricos

Ideação suicida passiva

O que parece na sessão: Paciente diz “seria melhor se eu não acordasse”, “às vezes penso que seria mais fácil não estar aqui”, “não sei se vale a pena continuar”. Não há plano, mas há desejo de desaparecimento.

Pergunta-chave:

“Quando você diz isso, você está pensando em fazer alguma coisa ou é mais uma sensação de querer sumir?”

Ação Amarelo: Registrar. Rastrear em toda sessão. Comunicar ao psiquiatra se persistir ou intensificar.

Ideação suicida com plano

O que parece na sessão: Paciente menciona método (“eu sei que tenho remédio em casa”), data, intenção clara. Ou diz que já decidiu.

Pergunta-chave:

“Você pensou em como faria? Tem acesso a algum meio agora?”

Ação Vermelho: Não deixar o paciente sair sozinho. Acionar psiquiatra imediatamente. Se não houver contato direto: familiar + SAMU se necessário.

Piora rápida e inexplicável

O que parece na sessão: Paciente que estava estável chega visivelmente diferente: mais retraído, mais vazio, mais agitado: sem evento precipitante claro.

Pergunta-chave:

“Algo mudou na medicação recentemente? Teve algum acontecimento que te abalou?”

Ação Amarelo: Investigar causa. Checar adesão medicamentosa. Comunicar ao psiquiatra se sem explicação clara.

Redução de sono sem cansaço

O que parece na sessão: Paciente relata dormir 3 a 4 horas e acordar com energia. Não sofre pela falta de sono: sente que não precisa dormir.

Pergunta-chave:

“Você está dormindo menos porque não consegue ou porque não sente necessidade? No dia seguinte, como está sua energia?”

Ação Amarelo: se episódio recente sem outros sinais. Ação Vermelho: se acompanhado de agitação, gastos impulsivos ou desorganização: pode indicar virada maníaca.

Agitação intensa e impulsividade

O que parece na sessão: Paciente mais acelerado que o habitual, interrompe, muda de assunto, relata decisões impulsivas (gastos, conflitos, relacionamentos), sente que está “em outro nível”.

Pergunta-chave:

“Isso é seu jeito normal ou você está diferente do que costuma ser?”

Ação Amarelo: se isolado e leve. Ação Vermelho: se associado a redução de sono, euforia ou consequências concretas: comunicar ao psiquiatra com urgência.

Desorganização do pensamento

O que parece na sessão: Discurso vago, perde o fio no meio da frase, responde tangencialmente, não termina ideias. Mudança perceptível em relação a sessões anteriores.

Pergunta-chave:

“Você está conseguindo organizar seus pensamentos normalmente?”

Ação Vermelho: Comunicar ao psiquiatra. Psicose em início tem janela de intervenção: não esperar.

Delírios, paranoia, estranhamento da realidade

O que parece na sessão: Paciente relata que “as coisas estão diferentes”, sensação de que algo acontece “por trás” das situações, que pessoas falam sobre ele, que eventos têm significado especial. Ou verbaliza crenças desconectadas da realidade.

Pergunta-chave:

“Quando você diz que as coisas estão estranhas, você consegue explicar melhor? É uma sensação interna ou o ambiente parece diferente?”

Ação Vermelho: Não confrontar o conteúdo. Acionar psiquiatra. Monitorar segurança.

Autolesão

O que parece na sessão: Paciente menciona ou você percebe marcas em braços, pernas. Relata que se machuca para “sentir algo” ou “aliviar” uma angústia.

Pergunta-chave:

“Você tem se machucado? Com que frequência? Está aumentando?”

Ação Amarelo: se histórico prévio sem agravamento atual. Ação Vermelho: se novo, crescente ou com intensidade importante : comunicar ao psiquiatra.

Dissociação intensa

O que parece na sessão: Paciente relata momentos de “sair do corpo”, não se reconhecer no espelho, sentir que está num sonho, lacunas de memória. Pode surgir ao abordar temas de trauma.

Pergunta-chave:

“Quando isso acontece, você sabe onde está? Consegue me dizer quanto tempo dura?”

Ação Amarelo: Investigar trauma. Não aprofundar conteúdo traumático sem manejo adequado. Comunicar ao psiquiatra se frequente ou intenso.

SEÇÃO 02

Sinais Medicamentosos

Acatisia

O que parece na sessão: Paciente diz que “não consegue ficar parado”, anda pela sala, levanta e senta, descreve inquietação corporal interna. Começou após início ou ajuste de medicação.

Pergunta-chave:

“Essa sensação é mais de preocupação ou de inquietação no corpo? Começou antes ou depois da medicação?”

Ação Amarelo: Nomear a hipótese para o paciente. Comunicar ao psiquiatra com urgência: acatisia pode aumentar risco de ideação suicida.

Sedação intensa

O que parece na sessão: Paciente relata dormir demais, dificuldade de acordar, “cabeça pesada” durante o dia, prejuízo no trabalho ou nas relações. Iniciou ou piorou com mudança medicamentosa.

Pergunta-chave:

“Isso começou quando? Tem relação com alguma mudança no remédio ou na dose?”

Ação Amarelo: Registrar e comunicar ao psiquiatra. Sedação excessiva compromete adesão.

Embotamento emocional

O que parece na sessão: Paciente diz “não estou triste, mas também não sinto nada”. Ausência de reatividade emocional. A terapia trava: concorda com tudo, mas nada avança. Iniciou após medicação ou ajuste de dose.

Pergunta-chave:

“Você está melhor ou está diferente? A tristeza passou ou todas as emoções ficaram mais baixas?”

Ação Amarelo: Comunicar ao psiquiatra: pode indicar necessidade de reavaliação da conduta.

Síndrome de descontinuação

O que parece na sessão: Paciente relata tontura, “choquinhos” no corpo (brain zaps), náusea, irritabilidade, instabilidade. Iniciou dias após parar ou reduzir medicação por conta própria.

Pergunta-chave:

“Você mudou ou parou algum remédio recentemente? Há quanto tempo está sentindo isso?”

Ação Amarelo: se sintomas leves. Ação Vermelho: se intensos ou com risco de descompensação: orientar retorno ao psiquiatra o quanto antes.

Sinais de dependência de benzodiazepínicos

O que parece na sessão: Paciente usa benzo diariamente há mais de 4 semanas. Relata que sem o remédio não dorme ou fica muito ansioso. Já precisou aumentar a dose para ter o mesmo efeito.

Pergunta-chave:

"O que acontece quando você não toma? Esses sintomas aparecem rápido e somem quando você toma?"

Ação Amarelo: Abrir conversa sem julgamento. Comunicar ao psiquiatra : retirada precisa ser gradual e supervisionada.

Efeitos extrapiramidais

O que parece na sessão: Paciente em uso de antipsicótico relata rigidez muscular, tremor, movimentos involuntários, postura diferente, dificuldade de se mover normalmente.

Pergunta-chave:

"Você notou alguma mudança no seu corpo desde que começou esse remédio? Rigidez, tremor, dificuldade de se mover?"

Ação Amarelo: Comunicar ao psiquiatra para avaliação e possível ajuste.

Galactorreia / hiperprolactinemia

O que parece na sessão: Paciente (homem ou mulher) em uso de antipsicótico relata secreção mamária, alteração de libido ou, em mulheres, irregularidade menstrual.

Pergunta-chave:

"Você notou algo diferente no seu corpo desde que começou essa medicação? Às vezes esses remédios podem causar alterações hormonais."

Ação Amarelo: Comunicar ao psiquiatra. Paciente pode não relatar espontaneamente por vergonha.

Ganho de peso rápido e importante

O que parece na sessão: Paciente relata ganho significativo de peso sem mudança de hábitos. Comum com alguns antipsicóticos e estabilizadores de humor.

Pergunta-chave:

"Você notou mudança no peso desde que começou ou ajustou a medicação?"

Ação Amarelo: Registrar. Comunicar ao psiquiatra: impacta adesão e saúde metabólica.

Disfunção sexual com risco de abandono

O que parece na sessão: Paciente relata perda de desejo, dificuldade de excitação ou orgasmo desde o início da medicação. Pode estar considerando parar o remédio.

Pergunta-chave:

"Você notou alguma mudança na sua vida sexual depois que começou a medicação?"

Ação Amarelo: Comunicar ao psiquiatra com urgência: é a principal causa de abandono silencioso de antidepressivos.

Virada maníaca por antidepressivo

O que parece na sessão: Paciente em uso de antidepressivo apresenta mudança abrupta: mais acelerado, eufórico, com redução de sono sem cansaço, impulsividade e sensação de estar "ótimo". Mudança inconsistente com linha de base.

Pergunta-chave:

"Essa energia que você está sentindo é parecida com seu jeito normal ou está além do que costuma ser?"

Ação Vermelho: Não reforçar como melhora. Comunicar ao psiquiatra com urgência: antidepressivo pode estar revelando bipolaridade subjacente.

Baixa adesão suspeita

O que parece na sessão: Melhora instável sem padrão claro, paciente menciona "esqueci" com frequência, resposta clínica inconsistente com o tempo de uso. Paciente desvia quando perguntado sobre rotina com o remédio.

Pergunta-chave:

"Me conta como foi sua rotina com o remédio essa semana: teve algum dia que esqueceu ou variou o horário?"

Ação Amarelo: Abrir sem julgamento. Registrar. Comunicar ao psiquiatra se persistente: baixa adesão mascara a eficácia real da medicação e pode levar a trocas desnecessárias.

Uso de substâncias interferindo no tratamento

O que parece na sessão: Tratamento sem evolução apesar de adesão aparente, humor instável fora do padrão esperado, insônia persistente sem causa clara, paciente evasivo sobre rotina social ou noturna.

Pergunta-chave:

"Muitas pessoas usam álcool, maconha ou outras substâncias para lidar com a ansiedade. Se for o seu caso, é importante que eu saiba: não para julgar, mas porque pode estar afetando o tratamento."

Ação Amarelo: Abrir sem julgamento. Se confirmado, comunicar ao psiquiatra com autorização do paciente: substâncias podem anular completamente a ação de antidepressivos e ansiolíticos.

Síndrome serotoninérgica

O que parece na sessão: Combinação de tremor, diarreia, sudorese excessiva, agitação, confusão mental e febre. Pode surgir após início ou aumento de antidepressivo, ou após combinação com outros serotoninérgicos (tramadol, alguns analgésicos, suplementos como 5-HTP).

Pergunta-chave:

"Quando exatamente esses sintomas começaram? Você tomou algum remédio novo, suplemento ou analgésico recentemente?"

Ação Vermelho: Emergência médica. Acionar psiquiatra ou PS imediatamente. Não minimizar: síndrome serotoninérgica grave pode ser fatal.

SEÇÃO 03

Sinais Clínicos / Orgânicos

Fadiga + queda de cabelo + lentidão intestinal

O que parece na sessão: Paciente relata cansaço desproporcional, queda de cabelo acentuada, pele seca, ganho de peso sem mudança de hábitos, intestino "travado". Pode estar em tratamento para depressão sem melhora adequada.

Pergunta-chave:

"Além do cansaço emocional, você notou alguma mudança física? Cabelo, pele, peso, intestino?"

Ação Amarelo: Orientar avaliação médica para investigar tireoide. Hipotireoidismo pode se apresentar como quadro depressivo.

Esquecimento progressivo + formigamento + apatia

O que parece na sessão: Paciente (especialmente idoso ou com problemas gástricos) relata esquecimento crescente, formigamento nas mãos ou pés, fraqueza, apatia. Pode ter histórico de uso prolongado de omeprazol ou redução de proteína animal na dieta.

Pergunta-chave:

"Você sente formigamento em alguma parte do corpo? Tem algum problema gástrico ou mudou sua alimentação recentemente?"

Ação Amarelo: Orientar avaliação médica para investigar vitamina B12 e outras causas clínicas possíveis. Deficiências prolongadas podem causar dano neurológico.

Perda de peso acentuada ou restrição alimentar

O que parece na sessão: Perda de peso visível entre sessões. Pele seca, cabelo quebradiço. Paciente relata restrição alimentar, rituais com comida, culpa após comer ou comportamentos compensatórios.

Pergunta-chave:

"Me conta como foi sua alimentação ontem, do começo ao fim do dia."

Ação Amarelo: se padrão restritivo sem sinais físicos graves. Ação Vermelho: se sinais físicos presentes (tontura, fraqueza, inchaço nas bochechas): encaminhar para avaliação clínica urgente. Transtorno alimentar tem a maior mortalidade entre os transtornos psiquiátricos.

Taquicardia + tremor + sudorese sem conteúdo ansioso

O que parece na sessão: Paciente descreve "corpo ligado o tempo todo", palpitações, tremor nas mãos, sudorese excessiva. Mas quando se investiga: não há preocupação específica. "A ansiedade começa no corpo, não na cabeça."

Pergunta-chave:

"Essa sensação começa como pensamento ou como algo físico? Você está preocupado com algo ou é o seu corpo que não para?"

Ação Amarelo: Orientar avaliação médica para investigar tireoide. Hipertireoidismo pode se apresentar como ansiedade corporal intensa.

Sintomas físicos incompatíveis com o quadro mental

O que parece na sessão: O quadro psiquiátrico não responde ao tratamento apesar de adesão adequada. Ou sintomas físicos acompanham os emocionais de forma desproporcional ou inconsistente.

Pergunta-chave:

“Esse padrão faz sentido como o quadro que a gente está tratando? Se não faz, o que mais pode ser?”

Ação Amarelo: Orientar avaliação médica. Considerar causa orgânica antes de interpretar tudo como piora emocional ou falha medicamentosa.

SEÇÃO 04

Frases de Apoio para Momentos Críticos

Use estas frases diretamente com o paciente quando necessário.

Para nomear preocupação sem alarmar

“Eu estou percebendo uma mudança importante e quero entender melhor com você.”

Para orientar sem pressionar

“Isso merece ser avaliado com mais rapidez. Não estou querendo te assustar: estou querendo te proteger.”

Para acionar rede sem dramatizar

“Vamos entrar em contato com seu psiquiatra agora. Eu te ajudo com isso.”

Para manter vínculo em crise

“Eu não vou te deixar sozinho com isso.”

Para criar urgência sem pânico

“Preciso que você fale com seu psiquiatra antes da nossa próxima sessão. Isso não pode esperar.”

Para sustentar após emergência

“O que aconteceu aqui foi difícil. Você não precisa carregar isso sozinho. Vamos seguir juntos.”

Comunicação com o psiquiatra

Quando precisar acionar o psiquiatra, organize a mensagem assim:

1. Identifique o paciente (iniciais + contexto mínimo)
2. Descreva o que observou (comportamento, fala, padrão: não diagnóstico)
3. Aponte a mudança (em relação a sessões anteriores)
4. Informe o nível de urgência (Amarelo: alinhar em breve / Vermelho: agir hoje)
5. Faça um pedido objetivo (reavaliação, orientação de conduta, ajuste)

“Paciente em uso de sertralina há três semanas, evoluindo com redução importante de sono sem cansaço, aceleração do pensamento e impulsividade com prejuízo financeiro. Mudança inconsistente com linha de base. Solicito reavaliação com urgência.”

Aprofunde a comunicação com o médico assistente com o Kit de Comunicação Clínica.
[Clique aqui e conheça](#)



Versão Resumida: Referência Rápida

Para imprimir e manter no consultório. Abrange todos os sinais deste checklist.

Sinal	Nível	Ação imediata
Ideação passiva (sem plano)	Amarelo	Rastrear toda sessão; comunicar se persistir
Ideação com plano ou intenção	Vermelho	Não deixar sair sozinho. Acionar agora
Piora rápida sem causa clara	Amarelo	Investigar, comunicar ao psiquiatra
Redução de sono sem cansaço	A / V	Investigar ativação maníaca
Agitação + impulsividade intensa	A / V	Comunicar ao psiquiatra
Desorganização do pensamento	Vermelho	Comunicar. Não esperar
Delírio / estranhamento da realidade	Vermelho	Acionar. Não confrontar conteúdo
Autolesão crescente	A / V	Comunicar ao psiquiatra
Dissociação frequente	Amarelo	Investigar trauma. Comunicar se intenso
Acatisia	Amarelo	Comunicar com urgência: risco de ideação
Sedação excessiva	Amarelo	Comunicar ao psiquiatra
Embotamento emocional	Amarelo	Comunicar: pode pedir reavaliação
Síndrome de descontinuação	A / V	Retorno ao psiquiatra urgente
Dependência de benzodiazepínicos	Amarelo	Não orientar parada abrupta. Comunicar
Disfunção sexual	Amarelo	Comunicar: principal causa de abandono silencioso
Virada maníaca por antidepressivo	Vermelho	Comunicar com urgência
Baixa adesão suspeita	Amarelo	Abrir sem julgamento, registrar, comunicar se persistir
Substâncias interferindo no tratamento	Amarelo	Abrir sem julgamento, comunicar com autorização
Síndrome serotoninérgica	Vermelho	Emergência: acionar PS imediatamente
Fadiga + cabelo + intestino lento	Amarelo	Orientar avaliação médica para investigar tireoide
Esquecimento + formigamento + apatia	Amarelo	Orientar avaliação médica para investigar B12/outras causas
Perda de peso + restrição alimentar	A / V	Avaliação clínica urgente se sinais físicos
Corpo acelerado sem conteúdo ansioso	Amarelo	Orientar avaliação médica para investigar tireoide
Quadro que não responde ao tratamento	Amarelo	Investigar causa orgânica

Checklist de Sinais de Atenção: Dra. Tatiana Gontijo: uso exclusivo para fins educativos: Este material não substitui avaliação clínica individualizada